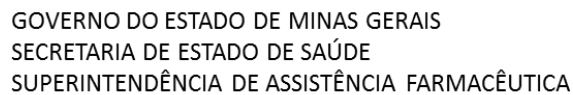




FORMULÁRIO ESPECÍFICO – HAP

1	NOME CIVIL DO(A) PACIENTE: Joao da Silva Teste NOME SOCIAL DO(A) PACIENTE:																		
2	DATA DE NASCIMENTO: / /																		
3	CID-10:																		
4	4.1 HIPERTENSÃO PULMONAR – INDICAR GRUPO: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V 4.2 INFORMAR: <table><tr><td>Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr><tr><td>Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?</td><td>SIM ☐</td><td>NÃO ☐</td></tr></table>	Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐									
Paciente possui fatores de risco ou dados ecocardiográficos compatíveis com doenças do coração esquerdo como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐																	
Paciente possui exames compatíveis com doenças pulmonares crônicas como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐																	
Paciente possui exames compatíveis com embolia pulmonar como causa de HP?	SIM ☐	NÃO ☐																	
5	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E EVOLUÇÃO DA DOENÇA: O paciente apresenta dispneia progressiva aos esforços há aproximadamente seis meses, associada a fadiga intensa e edema de membros inferiores, com piora clínica recente importante.																		
6	CATETERISMO CARDÍACO DIREITO: Data: / / <table><tr><td>☐</td><td>PAPm:</td><td> 45 mmHg </td></tr><tr><td>☐</td><td>POAP ou PDFVE:</td><td> </td></tr><tr><td>☐</td><td>RVP Wood:</td><td> </td></tr></table> PAPm: pressão arterial pulmonar média; POAP: pressão de oclusão da artéria pulmonar; PDFVE: pressão diastólica final do ventrículo esquerdo; RVP: resistência vascular pulmonar	☐	PAPm:	45 mmHg	☐	POAP ou PDFVE:		☐	RVP Wood:										
☐	PAPm:	45 mmHg																	
☐	POAP ou PDFVE:																		
☐	RVP Wood:																		
7	INFORMAR ETIOLOGIA DA DOENÇA: <table><tr><td>☐</td><td>7.1 HAP Idiopática, hereditária ou induzida por drogas. 7.1.1 Caso assinalado o item acima, indicar: TESTE DE REATIVIDADE COM ÓXIDO NÍTRICO: ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO Justificativa para não realização do teste: </td></tr><tr><td colspan="2">OU</td></tr><tr><td>☐</td><td>7.2 HAP associada 7.2.1 Caso assinalado o item acima, indicar enfermidade associada: <table><tr><td>☐</td><td>Colagenoses,</td></tr><tr><td>☐</td><td>Hipertensão Porto-pulmonar</td></tr><tr><td>☐</td><td>Esquistossomose</td></tr><tr><td>☐</td><td>HIV</td></tr><tr><td>☐</td><td>Cardiopatía congênita</td></tr><tr><td>☐</td><td>Veno-oclusiva</td></tr></table></td></tr></table>	☐	7.1 HAP Idiopática, hereditária ou induzida por drogas. 7.1.1 Caso assinalado o item acima, indicar: TESTE DE REATIVIDADE COM ÓXIDO NÍTRICO: ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO Justificativa para não realização do teste:	OU		☐	7.2 HAP associada 7.2.1 Caso assinalado o item acima, indicar enfermidade associada: <table><tr><td>☐</td><td>Colagenoses,</td></tr><tr><td>☐</td><td>Hipertensão Porto-pulmonar</td></tr><tr><td>☐</td><td>Esquistossomose</td></tr><tr><td>☐</td><td>HIV</td></tr><tr><td>☐</td><td>Cardiopatía congênita</td></tr><tr><td>☐</td><td>Veno-oclusiva</td></tr></table>	☐	Colagenoses,	☐	Hipertensão Porto-pulmonar	☐	Esquistossomose	☐	HIV	☐	Cardiopatía congênita	☐	Veno-oclusiva
☐	7.1 HAP Idiopática, hereditária ou induzida por drogas. 7.1.1 Caso assinalado o item acima, indicar: TESTE DE REATIVIDADE COM ÓXIDO NÍTRICO: ☐ POSITIVO ☐ NEGATIVO Justificativa para não realização do teste:																		
OU																			
☐	7.2 HAP associada 7.2.1 Caso assinalado o item acima, indicar enfermidade associada: <table><tr><td>☐</td><td>Colagenoses,</td></tr><tr><td>☐</td><td>Hipertensão Porto-pulmonar</td></tr><tr><td>☐</td><td>Esquistossomose</td></tr><tr><td>☐</td><td>HIV</td></tr><tr><td>☐</td><td>Cardiopatía congênita</td></tr><tr><td>☐</td><td>Veno-oclusiva</td></tr></table>	☐	Colagenoses,	☐	Hipertensão Porto-pulmonar	☐	Esquistossomose	☐	HIV	☐	Cardiopatía congênita	☐	Veno-oclusiva						
☐	Colagenoses,																		
☐	Hipertensão Porto-pulmonar																		
☐	Esquistossomose																		
☐	HIV																		
☐	Cardiopatía congênita																		
☐	Veno-oclusiva																		



8		MEDICAMENTOS SOLICITADOS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Medicamentos solicitado</th> <th style="width: 65%;">Posologia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Ambrisentana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Bosentana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Sildenafil</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Iloprosta</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Medicamentos solicitado	Posologia	☐ Ambrisentana		☐ Bosentana		☐ Sildenafil		☐ Iloprosta						
Medicamentos solicitado	Posologia																
☐ Ambrisentana																	
☐ Bosentana																	
☐ Sildenafil																	
☐ Iloprosta																	
9		RISCO ESTRATIFICADO (CONFORME PCDT): ☐ RISCO BAIXO ☐ RISCO INTERMEDIÁRIO ☐ RISCO ALTO Detalhar:															
10		CLASSE FUNCIONAL (NYHA/WHO-FC): ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV															
11		O PACIENTE APRESENTA ALGUMA DAS SITUAÇÕES DESCRITAS ABAIXO? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Doença hepática grave</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SIM ☐</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NÃO ☐</td> </tr> <tr> <td>Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar</td> <td style="text-align: center;">SIM ☐</td> <td style="text-align: center;">NÃO ☐</td> </tr> <tr> <td>Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)</td> <td style="text-align: center;">SIM ☐</td> <td style="text-align: center;">NÃO ☐</td> </tr> <tr> <td>Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia</td> <td style="text-align: center;">SIM ☐</td> <td style="text-align: center;">NÃO ☐</td> </tr> <tr> <td>Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC</td> <td style="text-align: center;">SIM ☐</td> <td style="text-align: center;">NÃO ☐</td> </tr> </tbody> </table>	Doença hepática grave	SIM ☐	NÃO ☐	Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐	NÃO ☐	Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐	NÃO ☐
Doença hepática grave	SIM ☐	NÃO ☐															
Suspeita ou alta probabilidade de doença pulmonar venoclusiva ou hemangiomatose pulmonar capilar	SIM ☐	NÃO ☐															
Paciente com HAP-I > 75 anos e com múltiplos fatores de risco para insuficiência cardíaca com FE preservada (hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito, doença arterial coronariana, fibrilação atrial, obesidade)	SIM ☐	NÃO ☐															
Paciente com HAP que permanecem estáveis e estratificados com baixo risco após tratamento prolongado (>5-10 anos) com monoterapia	SIM ☐	NÃO ☐															
Paciente com HAP-I, HAP-H ou HAP-D com teste de vasorreatividade pulmonar positivo em classe funcional I-II e resposta hemodinâmica sustentada após 1 ano de BCC	SIM ☐	NÃO ☐															



12	EXAMES COMPLEMENTARES:		
	Exames complementares	Data	Resultado
	Ecocardiograma		
	Eletrocardiograma		
	Espirometria		Resultado dentro dos parametros esperados para
	Teste de caminhada de 6 minutos (T6MC)		
	Polissonografia/Oximetria Noturna*		
	Angiotomografia de tórax ou Cintilografia Pulmonar de Perfusão		
	Ultrassonografia abdominal		
	Gasometria arterial		
Radiografia de Tórax			
Nyha: new york heart association. Who: world health organization. Fc: functional classification * Reservado aos pacientes com sintomatologia da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono (sahos).			
13	OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES:		
14	Assumo integral responsabilidade pela veracidade das informações prestadas.		
Data de preenchimento: / /			
Assinatura e carimbo: _____			
Médico			